

Trzy stany *różne ścieżki*

Wypalenie, depresja i zmęczenie wyglądają podobnie — wymagają zupełnie różnych interwencji. Test kontekstu rozstrzyga.

CZAS: 10 min Test wstępny + ewentualne narzędzia

ŹRÓDŁO: Bianchi, Schonfeld & Laurent (2015, *Clin Psychol Rev*); Ahola i in. (2014, longitudinalne, N = 3125); Maslach & Leiter (2016)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy stany w porównaniu**: wypalenie, depresja, zmęczenie przewlekłe (CFS) — różne mechanizmy, różne objawy, różne interwencje. W sekcji 02 — **test kontekstu**: cztery pytania różnicujące, w tym kluczowe pytanie urlopowe. W sekcji 03 — **algorytm interwencji** dla każdego stanu. Sekcja 04 — twoje samoobserwacje z ostatnich 4 tygodni.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bianchi, Schonfeld i Laurent (2015, *Clinical Psychology Review*): wypalenie i depresja nakładają się objawowo w **50-90%** — co utrudnia rozpoznanie. Trwa debata, czy wypalenie jest odrębnym konstruktem, czy wariantem depresji związanym z pracą. Klinicznie jednak: *nazwa* nie jest tu najważniejsza — kluczowe jest **zidentyfikowanie źródła**: czy objawy ograniczają się do kontekstu pracy, czy obejmują wszystkie sfery życia. Ahola i in. (2014, badanie longitudinalne, N = 3125): wypalenie **przewiduje** depresję, ale nie odwrotnie — wypalenie może być „drzwiami” do depresji. Implikacja kliniczna: jeśli zdiagnozujesz depresję u osoby, której objawy *znikają na urlopie*, przepiszysz lek przeciwdepresyjny zamiast zmienić warunki pracy — pacjent „leczy się” miesiącami bez efektu. Zmęczenie przewlekłe (CFS) ma jeszcze inny profil — dominuje wyczerpanie fizyczne, pogarsza się po wysiłku (zjawisko *post-exertional malaise*) i nie poprawia się po odpoczynku. Trzy różne stany, trzy różne ścieżki postępowania.

01 Trzy stany — porównanie

WYPALENIE

kontekst: praca

Co dominuje: wyczerpanie + cynizm + spadek skuteczności.

Kontekst: głównie sfera pracy.

Urlop: poprawa (przynajmniej początkowo).

Objawy wegetatywne: mniej wyrażone.

Interwencja: zmiana w pracy + regeneracja.

DEPRESJA

kontekst: wszystko

Co dominuje: obniżony nastrój + anhedonia + beznadziejność.

Kontekst: wszystkie sfery życia.

Urlop: brak poprawy.

Objawy wegetatywne: sen, apetyt, libido — wyraźnie zaburzone.

Interwencja: psychoterapia ± farmakoterapia.

ZMĘCZENIE PRZEWLEKŁE

somatyczne

Co dominuje: wyczerpanie fizyczne, pogorszenie po wysiłku (*post-exertional malaise*).

Kontekst: głównie soma.

Urlop: brak poprawy lub minimalna.

Objawy wegetatywne: sen niegodny, bóle.

Interwencja: medyczna diagnostyka.

02 Test kontekstu — cztery pytania

1 · TEST URLOPU

Czy objawy znikają (lub wyraźnie słabną) na **2-tygodniowym urlopie**? *Tak* → wypalenie. *Nie* → depresja albo współwystępowanie.

2 · TEST SFER ŻYCIA

Czy objawy ograniczają się do pracy, czy obejmują dom, hobby, relacje? *Tylko praca* → wypalenie. *Wszystko* → depresja prawdopodobna.

3 · TEST WYSIŁKU

Czy stan pogarsza się po wysiłku fizycznym i nie poprawia po odpoczynku? *Tak* → konieczna konsultacja medyczna i CFS.

4 · TEST BEZNADZIEJNOŚCI

Czy obecne są myśli typu „*nic nie ma sensu, to się nigdy nie zmieni*” niezwiązane z pracą? *Tak* → wskazana konsultacja psychiatryczna.

03 Algorytm interwencji — różne stany, różne ścieżki

JEŚLI WYPALENIE

Zmiana w środowisku pracy (granice, renegotiacja zakresu, wsparcie) + regeneracja (sen, ruch, sieć wsparcia). Plan 3–6 miesięcy. Sama farmakoterapia bez zmian w pracy zwykle nie wystarcza.

JEŚLI DEPRESJA

Konsultacja psychiatryczna. Psychoterapia (CBT, IPT) jako pierwsza linia. Farmakoterapia w umiarkowanej–ciężkiej depresji. Tu „samo wakacje” nie pomogą — wymaga aktywnego leczenia.

JEŚLI ZMĘCZENIE

Konsultacja medyczna (internista, neurolog) — wykluczenie tarczycy, niedokrwistości, niedoborów. Dopiero potem ocena somatyczno-psychologiczna. Nie zaczynaj od „popraw higienę snu”.

Często współwystępują. Bianchi i in. (2015): nakładanie się 50–90%. To, że pasuje jedno, nie znaczy, że nie pasuje też drugie. W razie wątpliwości — narzędzia przesiewowe (PHQ-9 + MBI lub OLBİ) używane razem. Niejednoznaczność jest informacją diagnostyczną, nie porażką oceny.

04 Twoje obserwacje z ostatnich 4 tygodni

TEST URLOPU

— czy miałeś/-aś urlop w ostatnich 6 mies.; czy objawy słabły

TEST SFER ŻYCIA

— gdzie objawy są obecne: praca, dom, hobby, relacje, sport

OBJAWY WEGETATYWNE

— sen, apetyt, libido, masa ciała — co się zmieniło

MYŚLI O PRZYSZŁOŚCI

— „nic nie ma sensu” / „to się nie zmieni” / myśli samobójcze — jeśli tak, konsultacja pilnie

Klucz: wypalenie może *prowadzić* do depresji, jeśli długo trwa bez zmian (Ahola i in., 2014). Wczesne rozpoznanie wypalenia jako wypalenia — nie błędne etykietowanie jako depresji — pozwala interweniować w sferze, w której problem rzeczywiście leży: **w pracy**. Jeśli masz wątpliwości lub objawy się nasilają — konsultacja z psychiatrą lub psychoterapeutą. To nie jest oznaka słabości, tylko racjonalne korzystanie ze specjalisty od narzędzia, którego potrzebujesz.

△ Ten handout to materiał psychoedukacyjny, nie zastępuje diagnozy. Jeśli pojawiają się myśli samobójcze, beznadziejności, plany samouszkodzenia — konsultacja pilnie (linia 116 123, izba przyjęć psychiatryczna, lekarz pierwszego kontaktu).